



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nomor: 813.1/I-PDM/DIR/IX/2025

Tentang

Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien

Disusun oleh :

Penanggung jawab BAB PAP



dr. Amanda Firmandani

Disetujui oleh :

Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M. Kes, AFP

Ditetapkan oleh :

Direktur RS Prima Husada Malang.



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada Malang

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim Regulasi yang telah bekerja memberikan masukan yang sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien ini, mutu sumber daya manusia di Rumah Sakit Prima Husada Malang dapat lebih baik.

Malang, 01 September 2026
Direktur RS Prima Husada Malang.



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN

Pengarah & Editor : Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CCHt., CI., CHAE., CHQP

Penyusun :

1. dr. Resti Lestantini, M. Kes
2. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
3. Puput Sekar, Amd. Keb
4. dr. Amanda Firmandani
5. Ns. Risma Indra Setiyani, S. Kep
6. Ericha Rsdawati, A.Md.Gz
7. Isa Ariyanti S. Kep.Ns
8. Kristina Ratih Dwi S, Amd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

PERATURAN DIREKTUR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 1

 1.3 Ruang Lingkup 2

BAB II PELAYANAN ASUHAN PASIEN 3

 2.1 asuhan Seragam 3

 2.1.1 Ketentuan Umum..... 3

 2.1.2 Tata Laksana Asuhan Pasien Seragam 3

 2.2 Asuhan Terintegrasi 3

 2.2.1 Tahapan Asuhan Terintegrasi..... 3

 2.2.2 Instruksi Dokter..... 4

 2.2.3 Prosedur Pemeriksaan Laboratorium dan Diagnostik Imaging 5

 2.2.4 Keterlibatan Keluarga dalam Asuhan Bersama..... 6

 2.3 Rencana Asuhan Pasien 7

 2.3.1 Ketentuan Umum..... 7

 2.3.1 Komponen Rencana Asuhan Pasien 7

BAB III PASIEN RISIKO TINGGI DAN PELAYANAN RISIKO TINGGI 9

 3.1 Pasien Risiko Tinggi..... 9

 3.1.1 Pasien Emergensi..... 9

 3.1.2 Pasien Koma 10

 3.1.3 Pasien dengan Alat Bantuan Hidup 11

 3.1.4 Pasien dengan Penyakit Jantung, Stoke, Diabetes 12

 3.1.5 Pasien dengan Risiko Bunuh Diri..... 13

 3.1.6 Risiko Tambahan pada Pasien Rsiiko Tinggi 14

 3.2 Pelayanan Risiko Tinggi 14

 3.2.1 Kriteria Pelayanan Risiko Tinggi 14

 3.2.2 Startegi Manajemen Pelayanan Risiko Tinggi..... 15

 3.3 Pelayanan Geriatri..... 15

 3.4 Program PKRS pada Pelayanan Geriatri 16

 3.5 Kesehatan Jiwa 18

 3.6. *Early Warning System* (ESW)..... 20

 3.6.1 EWS pada Pasien Dewasa 20

 3.6.2 EWS pada Pasien Anak..... 21

 3.7. Resusitasi..... 22

 3.8 Pelayanan Darah dan Produk Darah 23

BAB IV PEMBERIAN MAKANAN DAN TERAPI GIZI 25

 4.1 Proses Pelayanan dan Assesmen Gizi 25

 4.1.1 Skrinning Gizi 25

 4.1.2 Assesmen Gizi..... 25

 4.2 Prosedur Penentuan Kebutuhan Gizi 26

 4.3 Jenis Terapi Nutrisi..... 26

 4.4 Distribusi Makanan 26

 4.5 Pengelolaan Makanan dari Luar Rumah Sakit..... 27

 4.6 Edukasi Gizi Pasien..... 27

 5.1 Skrinning Nyeri 29

	5.1.1 Skrinning Nyeri pada Pasien Dewasa Sadar.....	30
	5.1.2 Skrinning Nyeri pada Pasien Anak.....	31
	5.1.3 Skrinning Nyeri pada Pasien Koma	31
	5.2 Tata Laksana Mengatasi Nyeri	32
	5.3 Edukasi Nyeri	33
BAB VI	PELAYANAN MENJELANG AKHIR KEHIDUPAN	34
	6.1 Skrinning Pelayanan Pasien Menjelang Akhir Kehidupan.....	34
	6.2 Proses Manajemen Pelayanan Menjelang Akhir Kehidupan.....	34
	6.3 <i>Do Not Resuscitate</i> (DNR).....	35
BAB VII	PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 3.5.1 Skoring EWS Pada Pasien Dewasa 17

Tabel 3.5.2.1 Skoring PEWS..... 18

Tabel 5.2.1 Intervensi Farmakologis Berdasarkan Tingkat Nyeri.....28

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR: 813.1/I-PDM/DIR/IX/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan dan asuhan kepada pasien rumah sakit merupakan hal pokok dalam pelayanan rumah sakit dan memerlukan acuan agar dapat dilaksanakan secara seragam, konsisten dan terintegrasi;
 - b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang Nomor 791.1/IPDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelayanan kesehatan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu adanya pembaharuan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 4. Undang – Undnag Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pei,J.Ksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Keselamatan Pasien;
 8. Kepdirjen Nomor HK.01.07./MENKES/1596/.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 9. Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman survei Akreditasi Rumah Sakit
 10. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
- (2) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;
- (3) Staf klinis adalah tenaga kesehatan yang memberikan asuhan langsung pada pasien;
- (4) Profesional Pemberi Asuhan adalah staf klinis profesional yang langsung memberikan asuhan kepada pasien;
- (5) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya;
- (6) Perawat Penanggung Jawab Asuhan adalah perawat yang bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya;
- (7) Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
- (8) Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan;
- (9) Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan / atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostic.
- (10) PKRS Adalah Promosi Kesehatan rumah Sakit

BAB II PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN

Pasal 2 Pelayanan dan Asuhan Pasien

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang Pelayanan dan Asuhan Pasien yang meliputi :
 - a. Pemberian pelayanan yang seragam
 - b. Pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan

- resiko tinggi
 - c. Pemberian makanan dan terapi nutrisi
 - d. Pengelolaan nyeri
 - e. Pelayanan menjelang akhir kehidupan
- (2) Asuhan yang seragam diberikan kepada setiap pasien meliputi:
- a. Akses untuk mendapatkan asuhan dan pengobatan tidak bergantung pada kemampuan pasien untuk membayar atau sumber pembayaran
 - b. Akses untuk mendapatkan asuhan dan pengobatan yang diberikan oleh PPA yang kompeten tidak bergantung pada hari atau jam 7 (tujuh) hari, 24 (dua puluh empat) jam.
 - c. Kondisi pasien menentukan sumber daya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhannya
 - d. Pemberian asuhan yang diberikan kepada pasien, sama disemua unit pelayanan di rumah sakit misalnya pelayanan anastesi
 - e. Pasien yang membutuhkan asuhan keperawatan yang sama akan menerima tingkat asuhan keperawatan yang sama disemua unit pelayanan di rumah sakit.

Pasal 3

Pelayanan dan Asuhan Terintegrasi

- (1) Rumah sakit melakukan pelayanan dan asuhan yang terintegrasi serta koordinasi kepada setiap pasien
- a. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai pimpinan klinis/ketua tim PPA (*clinical leader*)
 - b. PPA bekerja sebagai tim intra dan interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, dibantu antara lain dengan panduan praktik klinis (PPK), panduan asuhan PPA lainnya, alur klinis/clinical pathway terintegrasi, algoritma, protocol, prosedur, standing order, dan catatan perkembangan pasien (CPP) yang terintegrasi
 - c. Manajer Pelayanan Pasien (MPP)/*Case Manager* menjaga kesinambungan pelayanan
 - d. Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga dalam asuhan bersama PPA
 - 1) Asuhan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang unik berdasar atas pengkajian
 - 2) Rencana asuhan diberikan kepada tiap pasien
 - 3) Respons pasien terhadap asuhan dipantau
 - 4) Rencana asuhan dimodifikasi bila perlu berdasarkan respons pasien
- (2) Rumah Sakit menetapkan kewenangan pemberian instruksi oleh PPA yang kompeten, tata cara pemberian instruksi dan pendokumentasiannya
- (3) Permintaan pemeriksaan laboratorium dan 3 diagnostic imaging disertai indikasi klinis bila hasilnya berupa interpretasi
- (4) Prosedur dan tindakan sesuai instruksi dan PPA yang memberikan instruksi, alasan dilakukan prosedur atau tindakan serta hasilnya telah didokumentasikan didalam rekam

medis pasien

- (5) Pasien yang menjalani tindakan invasive atau beresiko di rawat jalan telah dilakukan pengkajian dan didokumentasikan dalam rekam medis

Pasal 4

Dokumentasi Rencana Asuhan Pasien

- (1) PPA membuat rencana asuhan untuk setiap pasien setelah diterima sebagai pasien rawat inap dalam waktu 24 jam berdasarkan hasil pengkajian awal
- (2) Rencana asuhan dievaluasi secara berkala, direvisi, atau dimutakhirkan serta didokumentasikan dalam rekam medis oleh setiap PPA
- (3) Instruksi berdasarkan rencana asuhan dibuat oleh PPA yang kompeten dan berwenang, dengan cara yang seragam, dan didokumentasikan di CPPT
- (4) Rencana asuhan pasien dibuat dengan membuat sasaran yang terukur dan di dokumentasikan
- (5) DPJP melakukan evaluasi atau review berkala dan verifikasi harian untuk memantau terlaksananya asuhan secara terintegrasi dan membuat notasi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PELAYANAN PASIEN RISIKO TINGGI DAN PENYEDIAAN PELAYANAN RISIKO TINGGI

Pasal 5

Pasien Berisiko Tinggi dan Pelayanan Berisiko Tinggi

- (1) Pimpinan Rumah Sakit melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan pada pasien berisiko tinggi dan pelayanan berisiko tinggi meliputi
 - a. Identifikasi pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi sesuai dengan populasi pasiennya disertai penetapan resiko tambahan yang mungkin berpengaruh pada pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi
 - b. Menetapkan prosedur, panduan praktik klinis (PPK), *clinical pathway* dan rencana perawatan
 - c. Melatih staf untuk menerapkan prosedur, panduan praktik klinis (PPK), *clinical pathway* dan rencana perawatan
- (2) Rumah sakit telah memberikan pelayanan pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi yang telah diidentifikasi berdasarkan populasi yaitu pasien anak, pasien dewasa, dan pasien geriatric meliputi
 - a. Rencana asuhan perawatan pasien
 - b. Perawatan terintegrasi dan mekanisme komunikasi antar PPA secara efektif
 - c. Pemberian informed consent
 - d. Pemantauan atau observasi pasien selama

- memberikan pelayanan
 - e. Kualifikasi atau kompetensi staf yang memberikan pelayanan
 - f. Ketersediaan dan penggunaan peralatan medis khusus untuk pemberian pelayanan
- (3) Pimpinan rumah sakit mengidentifikasi risiko tambahan yang dapat mempengaruhi pasien atau pelayanan resiko tinggi

Pasal 6 Pelayanan Geriatri

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit sesuai dengan kemampuan, sumber daya dan sarana prasarannya
- (2) Rumah sakit menetapkan tim terpadu geriatric dan telah menyelenggarakan pelayanan sesuai tingkat jenis layanan
- (3) Rumah sakit melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan geriatri
- (4) Ada pelaporan penyelenggaraan pelayanan geriatric rumah sakit

Pasal 7 Program PKRS Pada Pelayanan Geriatri

- (1) Ada program PKRS terkait Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut Usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based Community Geriatric Service*)
- (2) Rumah Sakit memberikan edukasi sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut Usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based Community Geriatric Service*)
- (3) Rumah sakit melaksanakan kegiatan sesuai program dan tersedia *leaflet* atau materi edukasi sebagai alat bantu kegiatan (brosur, leaflet, dan lain- lainnya).
- (4) Rumah sakit telah melakukan proses pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan kegiatan pelayanan secara berkala.

Pasal 8 Kesehatan Jiwa

- (1) Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan jiwa di rumah sakit sesuai dengan kemampuan pelayanan, sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan sumber daya lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah sakit telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan jiwa yang berkualitas dan menghargai hak-hak asasi orang dengan gangguan jiwa
- (3) Rumah sakit telah melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan jiwa

Pasal 9
Bunuh Diri

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi skrining, pengkajian dan mengelola serta menindak lanjuti risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri bagi semua pasien yang dirawat dirumah sakit
- (2) Rumah sakit menggunakan instrumen berbasis bukti untuk skrining dan pengkajian pasien risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri.
- (3) Rumah sakit menetapkan SPO tentang skrining, pengkajian, dan tatalaksana pencegahan risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri
- (4) Rumah sakit melatih sumber daya manusia yang mampu melakukan skrining, pengkajian, dan tata laksana pasien risiko bunuh diri
- (5) Rumah sakit melakukan pengkajian risiko lingkungan yang dapat digunakan dalam percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri; rumah sakit mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut.
- (6) Rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata Kelola pencegahan risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri

Pasal 10
NEWS

- (1) Rumah sakit menerapkan proses pengenalan perubahan kondisi pasien yang memburuk (EWS) dan mendokumentasikannya di dalam rekam medik pasien
- (2) Rumah sakit memiliki bukti PPA dilatih menggunakan EWS

Pasal 11
Resusitasi

- (1) Pelayanan resusitasi tersedia dan diberikan selama 24 jam setiap hari di seluruh area rumah sakit.
- (2) Peralatan medis untuk resusitasi dan obat untuk bantuan hidup dasar dan lanjut terstandar sesuai dengan kebutuhan populasi pasien.
- (3) Di seluruh area rumah sakit, bantuan hidup dasar diberikan segera saat dikenali henti jantung-paru dan bantuan hidup lanjut diberikan kurang dari 5 menit.
- (4) Staf diberi pelatihan pelayanan bantuan hidup dasar/lanjut sesuai dengan ketentuan rumah sakit

Pasal 12
Pelayanan Darah dan Produk Darah

- (1) Rumah sakit menerapkan penyelenggaraan pelayanan darah.
- (2) Pelayanan darah dan produk darah dilaksanakan sesuai dengan panduan klinis serta prosedur yang ditetapkan rumah sakit, meliputi :
 - a. Pemberian persetujuan (*Informed Consent*).
 - b. Permintaan darah
 - c. Tes kecocokan
 - d. Pengadaan darah
 - e. Penyimpanan darah
 - f. Identifikasi pasien
 - g. Distribusi dan pemberian darah
 - h. Pemantauan pasien dan respons terhadap reaksi tranfusi
- (3) Panduan klinis dan prosedur disusun dan diterapkan untuk pelayanan darah serta produk darah
- (4) Staf yang kompeten bertanggungjawab terhadap pelayanan darah dan produk darah serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB IV PEMBERIAN MAKANAN DAN TERAPI NUTRISI

Pasal 13 Pengelolaan Terapi Nutrisi

- (1) Berbagai pilihan makanan atau terapi nutrisi yang sesuai untuk kondisi, perawatan, dan kebutuhan pasien tersedia dan disediakan tepat waktu.
- (2) Sebelum pasien rawat inap diberi makanan, terdapat instruksi pemberian makanan dalam rekam medis pasien yang didasarkan pada status gizi dan kebutuhan pasien.
- (3) Untuk makanan yang disediakan keluarga, edukasi diberikan mengenai batasan- batasan diet pasien dan penyimpanan yang baik untuk mencegah kontaminasi, antara lain :
 - a. Makanan dari luar rumah sakit dapat diadakan sesuai ketentuan gizi rumah sakit
 - b. Pasien diberikan edukasi tentang batasan – batasan diet pasien dan penyimpanan yang baik untuk mencegah kontaminasi
- (4) Pemberian terapi gizi terintegrasi (rencana, pemberian dan evaluasi) pada pasien risiko gizi didokumentasikan dalam rekam medis
- (5) Terapi gizi terintegrasi didokumentasikan dengan metode IAR oleh Dietisien dan direview / verifikasi oleh DPJP
- (6) Pemantauan dan evaluasi terapi gizi dicatat di rekam medis pasien.

BAB V

PENGELOLAAN NYERI

Pasal 12

Manajemen Nyeri

- (1) Rumah sakit memiliki proses untuk melakukan skrining, pengkajian, dan tata laksana nyeri
 - a. Identifikasi pasien dengan rasa nyeri pada pengkajian awal dan pengkajian ulang
 - b. Pemberian informasi kepada pasien bahwa rasa nyeri dapat merupakan akibat dari terapi, prosedur, atau pemeriksaan
 - c. Tata laksana untuk mengatasi rasa nyeri, terlepas dari mana nyeri berasal
 - d. Komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pengelolaan nyeri sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai yang dianut.
 - e. Edukasi kepada seluruh PPA mengenai pengkajian dan pengelolaan nyeri
- (2) Informasi mengenai kemungkinan adanya nyeri dan pilihan tata laksananya diberikan kepada pasien yang menerima terapi/ prosedur/ pemeriksaan terencana yang sudah dapat diprediksi menimbulkan rasa nyeri.
- (3) Pasien dan keluarga mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan nyeri sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai yang dianut.
- (4) Staf rumah sakit mendapatkan pelatihan mengenai cara melakukan edukasi bagi pengelolaan nyeri.

BAB VI

PELAYANAN MENJELANG AKHIR KEHIDUPAN

Pasal 13

Pelayanan Menjelang Akhir Kehidupan

- (1) Rumah sakit menerapkan pengkajian pasien menjelang akhir kehidupan dan dapat dilakukan pengkajian ulang sampai pasien yang memasuki fase akhir kehidupannya, meliputi:
 - 1) Gejala dan respons pasien, termasuk mual, kesulitan bernapas, dan nyeri.
 - 2) Faktor yang memperparah gejala fisik
 - 3) Orientasi spiritual pasien dan keluarganya, termasuk keterlibatan dalam kelompok agama tertentu
 - 4) Keprihatinan spiritual pasien dan keluarganya, seperti putus asa, penderitaan, rasa bersalah.
 - 5) Status psikososial pasien dan keluarganya, seperti kekerabatan, kelayakan perumahan, pemeliharaan lingkungan, cara mengatasi, reaksi pasien dan keluarganya menghadapi penyakit
 - 6) Kebutuhan bantuan atau penundaan layanan untuk pasien dan keluarganya

- 7) Kebutuhan alternatif layanan atau tingkat layanan
 - 8) Faktor risiko bagi yang ditinggalkan dalam hal cara mengatasi dan potensi reaksi patologis
 - 9) Pasien dan keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan asuhan, termasuk keputusan *do not resuscitate/DNR*.
- (2) Asuhan menjelang akhir kehidupan ditujukan terhadap kebutuhan psikososial, emosional, kultural dan spiritual pasien dan keluarganya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 791.1/IPDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 September 2025
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
MALANG
NOMOR 813.1/I-PDM/DIR/IX/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN DAN ASUHAN
PASIEN

PEDOMAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia atau yang sering disebut dengan Personalia adalah suatu bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan pemenuhan sumber daya manusia khususnya Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang sesuai dengan standar profesi dan mempunyai kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan. Seleksi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) tersebut harus dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan dari setiap Satuan Kerja yang ada di rumah sakit.

Untuk dapat menunjang pencapaian dalam hal pelayanan maka proses Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan sebuah pedoman kerja sehingga didapatkan hasil yang baik dan bermutu. Pelayanan yang bermutu di rumah sakit akan membantu setiap staf untuk dapat berkarya sesuai dengan profesi, pendidikan, serta kemampuan yang dimiliki, membantu proses pelayanan pada pasien di rumah sakit sehingga pasien yang datang berobat ke rumah sakit merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, yang berarti pula customer tersebut nantinya akan sebagai sarana dalam mempromosikan rumah sakit. Keuntungan lain jika pasien cepat sembuh adalah mereka dapat segera Kembali mencari nafkah untuk diri dan keluarga.

Pendidikan atau pelatihan adalah alat untuk mengubah, maka untuk perubahan yang dapat dilakukan oleh perorangan, group dan organisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas. Pelatihan sangat penting dalam rangka mengubah dari yang terlatih menjadi lebih mahir dan dari yang belum terlatih menjadi terlatih.

Dalam manajemen sumber daya manusia juga dibahas tentang pelatihan dan pengembangan sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu penunjang untuk mencapai mutu pelayanan suatu perusahaan menjadi lebih optimal.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien adalah digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan dan asuhan pasien.

1.2.2 Tujuan

1. Memberikan pelayanan pasien yang komprehensif, bermutu dan aman.
2. Menjamin asuhan pasien sesuai kebutuhan medis, keperawatan, gizi, psikososial dan spiritual.

-
3. Melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan.

1.3 Ruang Lingkup

1. Asesmen pasien
2. Perencanaan asuhan
3. Implementasi pelayanan
4. Koordinasi antar unit
5. Evaluasi dan tindak lanjut
6. Discharge planning

BAB II

PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN

2.1 Asuhan Seragam

2.1.1 Ketentuan Umum

- a. Setiap pasien menerima asuhan yang seragam, adil, tidak diskriminatif dan sesuai kebutuhan pasien.
- b. Asuhan pasien harus berkesinambungan mulai dari penerimaan, penilaian awal, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi dan pemulangan pasien
- c. Semua asuhan pasien wajib di dokumentasikan dalam rekam medis sesuai standar dan peraturan.

2.1.2 Tata laksana asuhan pasien seragam

- a. Penerimaan pasien
 1. Verifikasi identitas pasien dengan 2 identitas
 2. Pemberian informasi hak dan kewajiban pasien.
 3. Persetujuan umum (*general consent*) untuk perawatan
- b. Pengkajian awal
 1. Dilakukan oleh dokter, perawat dan tenaga Kesehatan lain sesuai kewenangan
 2. Mencakup aspek medis, keperawatan, psikologis, social, budaya, spiritual, risiko jatuh, risiko nyeri dan status gizi.
 3. Hasil pengkajian menjadi dasar rencana asuhan
- c. Perencanaan asuhan
 1. Disusun bersama oleh tim multidisiplin (dokter, perawat, farmasi, gizi, fisioterapi, dll)
 2. Mengacu pada *clinical pathway* atau panduan praktik klinis (PPK).
 3. Disesuaikan dengan kebutuhan pasien
- d. Pelaksanaan asuhan
 1. Dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangan
 2. Menerapkan prinsip keselamatan pasien (6 sasaran keselamatan pasien)
 3. Melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan.
- e. Koordinasi dan kolaborasi
 1. Komunikasi efektif antar tenaga Kesehatan
 2. Rapat tim atau case conference bila diperlukan.
- f. Monitoring dan evaluasi
 1. Evaluasi kondisi pasien dilakukan secara berkala
 2. Penyesuaian rencana asuhan sesuai perkembangan klinis
- g. Pemulangan dan tindak lanjut
 1. Disusun rencana pemulangan (*discharge planning*) sejak awal perawatan.
 2. Ringkasan pulang, resep, edukasi pasien dan keluarga, serta rujukan bila perlu harus diberikan
 3. Tindak lanjut atau kontrol dicatat di rekam medis.

2.2 Asuhan Terintegrasi

2.2.1 Tahapan asuhan pasien terintegrasi

- a. Penerimaan pasien
 1. Identifikasi pasien dengan benar.
 2. Informasi hak dan kewajiban pasien, serta tanda tangan *general consent*.

3. Pengkajian awal oleh dokter, perawat dan bila perlu PPA lain.
- b. Pengkajian dan diagnosa
 1. Pengkajian awal komprehensif oleh tim (medis, keperawatan, gizi, farmasi, fisioterapi, dll)
 2. Identifikasi masalah pasien secara multidisiplin
 3. Penetapan diagnose medis dan masalah keperawatan/ Kesehatan lain.
- c. Perencanaan asuhan terintegrasi
 1. Disusun bersama dalam tim multidisiplin
 2. Mengacu pada *clinical pathway* atau PPK
 3. Rencana mencakup kebutuhan medis, keperawatan, nutrisi, farmasi, rehabilitasi, psikologis, social, dan spiritual.
 4. Melibatkan pasien dan keluarga dalam penyusunan rencana.
- d. Pelaksanaan asuhan
 1. Dilaksanakan oleh masing – masing profesi sesuai kewenangan.
 2. Penerapan prinsip keselamatan pasien (6 sasaran keselamatan pasien)
 3. Kolaborasi antar profesi dalam pemberian intervensi.
- e. Koordinasi dan komunikasi efektif
 1. Dilakukan melalui visite bersama, case conference atau metode komunikasi SBAR.
 2. Hasil koordinasi dicatat dalam rekam medis terintegrasi.
- f. Monitoring dan evaluasi
 1. Monitoring kondisi pasien dilakukan secara berkala oleh seluruh profesi terkait.
 2. Evaluasi hasil intervensi, pencapaian tujuan dan revisi rencana bila diperlukan.
- g. Pemulangan dan rencana tindak lanjut (*discharge planning*)
 1. Disusun sejak awal perawatan
 2. Melibatkan tim multidisiplin, pasien dan keluarga.
 3. Ringkasan pulang, edukasi, resep, kontrol dan rujukan diberikan.

2.2.2 Instruksi Dokter

- a. Ketentuan Umum
 - 1) DPJP Adalah dokter/dokter gigi yang ditetapkan oleh rumah sakit untuk bertanggung jawab atas pelayanan medis pasien.
 - 2) Semua instruksi DPJP wajib jelas, tertulis, ditandatangani dan terdokumentasi dalam rekam medis.
 - 3) Instruksi DPJP dapat disampaikan
Tertulis → dalam rekam medis, status pasien atau lembar instruksi
 - 4) Lisan/telepon → hanya dalam keadaan darurat/ urgent, dengan kewajiban konfirmasi tertulis maksimal 1x24 jam.
 - 5) Instruksi harus menggunakan bahasa medis yang standar, mudah dipahami, tidak ambigu dan sesuai terminologis klinis.
 - 6) Instruksi DPJP meliputi : pemeriksaan, terapi (farmakologis/non farmakologis), diet, observasi klinis, perawatan khusus, tindakan medis/operasi dan rencana tindak lanjut.
 - 7) Perawat atau tenaga Kesehatan lain yang menerima instruksi wajib melakukan verifikasi ulang (read back) untuk menghindari kesalahan komunikasi.
- b. Tatalaksana Instruksi DPJP

1) Pemberian instruksi

- DPJP melakukan pengkajian kondisi pasien sebelum memberikan instruksi
- Instruksi ditulis secara lengkap, meliputi :
 - Nama dan identitas pasien
 - Tanggal dan jam instruksi
 - Diagnosis kerja
 - Instruksi spesifik (obat, tindakan, diet, pemeriksaan, monitoring)
 - Tanda tangan dan nama jelas DPJP
- Untuk instruksi obat, wajib ditulis dosis, cara pemberian, frekuensi dan lama pemberian

2) Pelaksanaan instruksi

- Instruksi DPJP dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangan
- Pelaksanaan dicatat di rekam medis dengan nama petugas pelaksana
- Perawat wajib melaporkan hasil pelaksanaan instruksi, perubahan kondisi pasien, atau kendala kepada DPJP

3) Instruksi lisan/telepon

- Hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat
- Instruksi harus di *read back* oleh penerima (perawat/apoteker)
- Dicatat dalam rekam medis menggunakan SBAR
- DPJP wajib menandatangani konfirmasi instruksi tersebut.

4) Evaluasi instruksi

- DPJP mengevaluasi efektifitas instruksi pada saat visite.
- Instruksi yang tidak relevan atau sudah selesai harus di verifikasi, diberi tanda tangan/ paraf dan tanggal
- Evaluasi didokumentasikan dalam catatan perkembangan pasien.

2.2.3 Prosedur permintaan pemeriksaan laboratorium dan diagnostic imaging

a. Ketentuan umum

- 1) Permintaan pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh DPJP atau dokter yang mendapat delegasi kewenangan sesuai regulasi.
- 2) Permintaan pemeriksaan harus jelas, tertulis, terdokumentasi dalam rekam medis atau system elektronik
- 3) Permintaan lisan hanya diperbolehkan dalam keadaan gawat darurat, wajib dikonfirmasi tertulis maksimal 1x24 jam
- 4) Permintaan harus sesuai indikasi medis, *clinical pathway*, dan tidak boleh dilakukan berulang tanpa dasar klinis.
- 5) Pemeriksaan dilakukan setelah ada persetujuan pasien/ keluarga (*informed consent*) khusus untuk pemeriksaan dengan risiko tertentu)

b. Tata laksana permintaan pemeriksaan

1) Pengisian formulir/ permintaan elektronik

Formulir permintaan harus mencantumkan:

- a) Identitas pasien (nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, jenis kelamin).
- b) Unit/ ruangan asal pasien
- c) Nama dan tanda tangan dokter peminta

- d) Diagnosis/ dugaan klinis/ indikasi pemeriksaan.
 - e) Jenis pemeriksaan yang diminta
 - f) Waktu/ jam permintaan (biasa/ segera/urgent)
 - g) Informasi klinis tambahan yang relevan (alergi, riwayat penyakit, obat – obatan yang sedang digunakan)
 - h) Untuk radiologi dengan kontras : status fungsi ginjal, alergi, serta tanda tangan pasien/ keluarga di lembar persetujuan tindakan.
- 2) Proses permintaan
- a) Dokter/DPJP mengisi formulir permintaan dengan lengkap dan jelas
 - b) Perawat mengirim pasien atau sampel ke laboratorium/ radiologi sesuai prosedur.
 - c) Unit laboratorium/ radiologi melakukan verifikasi permintaan : identitas pasien, indikasi pemeriksaan, dan kelengkapan permintaan
 - d) Pemeriksaan dilakukan sesuai standar profesi dan SPO yang berlaku
 - e) Hasil pemeriksaan dikirimkan kembali ke DPJP dan diinput ke rekam medis pasien
- 3) Pelayanan Darurat (Cito)
- a) Untuk kondisi gawat darurat, pemeriksaan dilakukan segera setelah permintaan diterima.
 - b) Harus diberi tanda “cito” pada formulir atau system elektronik.
 - c) Hasil pemeriksaan segera diinformasikan ke DPJP/ perawat pengirim melalui komunikasi efektif.

2.2.4 Keterlibatan keluarga dalam asuhan bersama

- a. Pengkajian awal dan perencanaan asuhan
 - 1) Memberikan informasi riwayat Kesehatan pasien (medis, keperawatan, psikososial, spiritual)
 - 2) Menyampaikan kebiasaan, budaya, atau kepercayaan pasien yang dapat mempengaruhi asuhan
 - 3) Ikut serta dalam penyusunan rencana asuhan pasien bersama tim multidisiplin (dokter, perawat, farmasi, gizi, fisioterapi, psikologi)
- b. Edukasi pasien dan keluarga
 - 1) Menerima penjelasan dari tenaga Kesehatan tentang diagnosis, rencana perawatan, prosedur, obat, diet dan tindakan medis.
 - 2) Mendapatkan edukasi mengenai cara merawat pasien di rumah (perawatan luka, minum obat, diet, Latihan fisik, dsb)
 - 3) Memahami tanda bahaya yang harus diwaspadai dan kapan harus kembali ke rumah sakit.
- c. Persetujuan dan Keputusan klinis
 - 1) Menandatangani informed consent untuk tindakan medis/ invasive sesuai regulasi.
 - 2) Ikut dalam pengambilan Keputusan bila pasien tidak mampu (misalnya pasien tidak sadar atau anak).
 - 3) Mendampingi pasien saat diskusi tentang pilihan terapi atau rencana tindak lanjut.
- d. Asuhan harian selama perawatan
 - 1) Mendampingi pasien dalam aktivitas dasar (makan, mobilisasi ringan, komunikasi)
 - 2) Membantu tenaga Kesehatan dalam memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada pasien.

- 3) Berperan sebagai pengawas kepatuhan pasien (misalnya penggunaan obat atau diet).
- e. Keselamatan pasien
 - 1) Ikut serta dalam identifikasi pasien (misalnya mengingatkan jika gelang identitas lepas).
 - 2) Mengingatkan pasien untuk mencegah risiko jatuh atau infeksi.
 - 3) Menjadi pendamping pasien saat transportasi antar unit
 - 4) Menjadi saksi komunikasi hasil pemeriksaan penting atau instruksi medis, bila pasien membutuhkan.
- f. Rencana pemulangan (discharge planning)
 - 1) Terlibat sejak awal dalam perencanaan pemulangan pasien.
 - 2) Mengetahui jadwal kontrol, obat – obatan, diet, Latihan atau terapi lanjutan.
 - 3) Mendapatkan rujukan ke fasilitas Kesehatan lain bila diperlukan
 - 4) Diberikan informasi tentang kontak rumah sakit jika terjadi kondisi gawat darurat pasca pulang.

2.3 Rencana Asuhan Pasien

2.3.1 Ketentuan umum

- a. Rencana asuhan pasien disusun untuk setiap pasien rawat inap, rawat jalan tertentu, IGD maupun pasien dengan kondisi khusus sesuai standar pelayanan.
- b. Rencana asuhan pasien disusun segera setelah pengkajian awal dan diperbarui sesuai kondisi pasien
- c. Rencana asuhan pasien bersifat multidisiplin dan terintegrasi (medis, keperawatan, farmasi, gisi, fisioterapi).
- d. Rencana asuhan pasien harus melibatkan pasien dan keluarga dalam penyusunan serta persetujuan.
- e. Rencana asuhan pasien wajib terdokumentasikan dalam rekam medis terintegrasi melalui SIMRS.

2.3.2 Komponen rencana asuhan pasien

- a. Identitas pasien
 - Nama, nomor rekam medis, usia, jenis kelamin, unit/ruangan
- b. Hasil pengkajian awal
 - Kondisi medis, keperawatan, psikologis, social, spiritual, risiko (jatuh, nyeri, malnutrisi, dll)
- c. Diagnosa/ permasalahan
 - Diagnosa medis oleh DPJP
 - Diagnosa keperawatan
 - Masalah gizi, farmasi, fisioterapi
- d. Tujuan asuhan
 - Jangka pendek → stabilisasi kondisi pasien
 - Jangka Panjang → penyembuhan, rehabilitasi, pencegahan komplikasi
- e. Rencana intervensi
 - Medis : terapi obat, tindakan medis, pemeriksaan penunjang
 - Keperawatan : observasi, perawatan luka, manajemen nyeri, edukasi
 - Farmasi : pemantauan obat, konseling, terapi individual
 - Gizi : diet sesuai kondisi, pemantauan asupan nutrisi
 - Fisioterapi/ rehabilitasi : Latihan fisik, mobilisasi
- f. Kolaborasi tim

-
- Menetapkan siapa melakukan apa, kapan dan bagaimana
 - Menggunakan komunikasi efektif

BAB III

PELAYANAN PASIEN RISIKO TINGGI DAN PENYEDIAAN PELAYANAN RISIKO TINGGI

3.1. Daftar Pasien Risiko Tinggi Dan Meliputi:

- 3.1.1. Pasien emergensi;
- 3.1.2. Pasien koma;
- 3.1.3. Pasien dengan alat bantuan hidup;
- 3.1.4. Pasien risiko tinggi lainnya yaitu pasien dengan penyakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes dan kanker;
- 3.1.5. Pasien dengan risiko bunuh diri;

3.2. Daftar Pelayanan Risiko Tinggi antarlain:

- 1) Pelayanan pasien dengan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa;
- 2) Pelayanan pada pasien dengan “immuno-suppressed”;
- 3) Pelayanan pada pasien yang mendapatkan pelayanan dialisis;
- 4) Pelayanan pada pasien yang direstrain;
- 5) Pelayanan pada pasien yang menerima kemoterapi;
- 6) Pelayanan pasien paliatif;
- 7) Pelayanan pada pasien yang menerima radioterapi;
- 8) Pelayanan pada pasien terapi hiperbarik
- 9) Pelayanan radiologi intervensi;
- 10) Pelayanan pada populasi pasien rentan, pasien lanjut usia (geriatri) misalnya anak – anak dan pasien berisiko tindak kekerasan atau diterlantarkan.
- (11) Pelayanan pada pasien yang dilakukan tindakan khusus
 - a) Pasien luka decubitus
 - b) Cedera neurologis
 - c) Infeksi penggunaan ventilator
 - d) Infeksi saluran/ slang central
 - e) Pasien jatuh

3.1.1 Pasien emergensi

a. Penatalaksanaan pasien emergensi di IGD

1) Menerima pasien emergensi

- Pasien datang melalui pintu IGD, ambulans atau rujukan
- Dilakukan triase cepat oleh perawat terlatih
 - Merah → resusitasi segera
 - Kuning → darurat stabil, perlu observasi
 - Hijau → Tidak darurat, bis amenuunggu
 - Hitam → meninggal
- Catat jam kedatangan dan hasil triase

2) Penatalaksanaan awal (Prinsip ABCDE)

- A – Airway → pastikan jalan napas terbuka, pasang OPA/NPA/ETT bila perlu
- B – Breathing → berikan oksigen, bantu ventilasi, pasang monitor saturasi O₂
- C – Circulation → cek nadi, tekanan darah, pasang jalur IV, cairan resusitasi, kontrol perdarahan
- D – Disability → cek GCS, pupil, kontrol kejang
- E – Exposure → buk apakaian, cek trauma/ perdarahan, cegah hiponatremi

- 3) Melakukan resusitasi dan stabilisasi
 - Melakukan resusitasi jantung paru sesuai kebutuhan
 - Memberikan obat emergensi sesuai indikasi
 - Monitor tanda vital terus menerus
- 4) Melakukan kolaborasi tim
 - Dokter IGD sebagai penanggung jawab medis utama
 - Perawat IGD melakukan tindakan keperawatan emergensi
 - Unit penunjang segera merespon permintaan pemeriksaan penunjang dan obat emergensi
- 5) Keputusan tindak lanjut
Setelah stabil → pasien dapat
 - Dirawat di ICU/ruang rawat inap
 - Dibawa ke kamar operasi bila perlu tindakan operatif emergensi
 - Dirujuk ke RS lain bila fasilitas tidak memadai (melalui SPGDT – Sistem Pelayanan gawat Darurat Terpadu)
- 6) Komunikasi dan edukasi
 - Menyampaikan kondisi pasien, tindakan dan rencana tindak lanjut kepada keluarga dengan jelas
 - Dokumentasi komunikasi dan persetujuan tindakan (informed consent)
- 7) Dokumentasi
 - Semua tindakan dicatat dalam rekam medis IGD
 - Menggunakan format standar
 - Melakukan handover antar tenaga kesehatan dengan metode SBAR

b. Penatalaksanaan pasien emergensi di rawat inap

- 1) Mengidentifikasi kondisi emergensi
 - Henti jantung/ pernapasan
 - Sesak berat, saturasi O₂ <90% dengan oksigen
 - Penurunan kesadaran mendadak (GCS <8)
 - Kejang berulang
 - Syok (tekanan darah turun, nadi lemah)
 - Perdarahan masif
 - Nyeri dada mendadak dengan tanda iskemia jantung
- 2) Melakukan tindakan awal perawat
 - Mengaktifkan alarm Code Blue
 - Melakukan ABCD
 - Airway : pastikan jalan napas terbuka
 - Breathing : berikan O₂ bantu ventilasi jika perlu
 - Circulation : monitor nadi, tekanan darah, pasang jalur IV, cairan resusitasi
 - Disability : cek kesadaran, kontrol kejang
 - Exposure : cek kondisi tubuh, perdarahan, trauma
 - Memasang monitor pasien
- 3) Melakukan koordinasi dan kolaborasi
 - Menghubungi dokter jaga
 - Jika kondisi kritis, menghubungi dokter spesialis terkait
 - Koordinasi dengan unit penunjang (lab, radiologi, farmasi)

- 4) Melakukan resusitasi dan Stabilisasi
 - Melakukan resusitasi sesuai kondisi
 - Memberikan obat emergensi sesuai instruksi dokter
 - Stabilisasi pasien (jalan napas, oksigen, cairan, obat, monitoring)
- 5) Melakukan tindak lanjut
 - Setelah stabil → pasien dapat
 - Tetap dirawat di ruang rawat inap dengan monitoring ketat
 - Dipindahkan ke ICU
 - Dibawa ke kamar operasi jika perlu tindakan operatif emergensi
 - Bila dirumahnya akit tidak mampu menangani → melakukan rujuk eksternal sesuai prosedur SPGDT (Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu)
- 6) Pendokumentasian
 - Mencatat semua kondisi awal, waktu kejadian, tindakan, obat yang diberikan, respon pasien, serta keputusan tindak lanjut pada rekam medis terintegrasi
 - Menggunakan format lembar Code Blue
 - Dokumentasi handover menggunakan metode SBAR

3.1.2 Pasien koma

Penatalaksanaan pasien koma, antara lain;

- a. Melakukan stabilisasi awal (ABCD Resusitasi)
- b. Menentukan diagnosis dan penyebab
 - 1) Pemeriksaan laboratorium
 - 2) Pemeriksaan penunjang
 - 3) Konsultasi spesialis sesuai indikasi
- c. Melakukan penatalaksanaan khusus sesuai etiologi
- d. Asuhan terintegrasi
 - 1) Dokter → diagnosis, terapi medis, pemantauan
 - 2) Perawat → pemantauan GCS, tanda vital, perawatan jalan napas, pencegahan luk atekan, pemasangan kateter dan NGT bila perlu
 - 3) Apoteker → memastikan keamanan penggunaan obat emergensi
 - 4) Nutrisionist → pemberian nutrisi enteral/parenteral sesuai kondisi
 - 5) Fisioterapi → mobilisasi pasief untuk mencegah kontraktur bila stabil
- e. Melakukan pencegahan komplikasi
- f. Melakukan komunikasi dan edukasi
 - 1) Menggunakan komunikasi efektif anatar tenaga kesehatan
 - 2) Memeberikan informasi kepada keluarga tentang kondisi pasien, rencana perawatan dan prognosis
 - 3) Mendapatkan informed consent untuk tindakan invasif
- g. Dokumentasi
 - 1) Catat awal masuk : status neurologis, GCS, tanda vital
 - 2) Lembar observasi pasien ; GCS, pupil, respirasi tanda vital, sirkulasi, intake – output
 - 3) Catatan asuhan terintegrasi (dokter, perawat, apoteker gizi)
 - 4) Dokumentasi edukasi pasien dan keluarga

3.1.3 Pasien dengan alat bantuan hidup

Penatalaksanaan pasien dengan alat bantuan hidup meliputi :

- a. Asesmen awal dan berkelanjutan
 - 1) Lakukan triase cepat pada pasien emergensi
 - 2) Asesmen fungsi vital : jalan napas, pernapasan, sirkulasi, kesadaran (ABCDE)
 - 3) Tentukan indikasi alat bantuan hidup
 - 4) Lakukan asesmen berkala setiap jam (perawat) dan sesuai kondisi klinis (dokter)
- b. Stabilisasi pemasangan alat
 - 1) Ventilasi mekanik
 - Indikasi ; GCS < 8, gagal napas, hipoksemia, distress pernapasan
 - Lakukan intubasi dengan teknik aseptik (oleh dokter anestesi)
 - Atur mode ventilator sesuai kebutuhan pasien (sesuai instruksi dokter anestesi)
 - 2) Defibrilator
 - Pasang sesuai protocol ACLS (dilakukan oleh dokter jaga/ dokter anestesi/ DPJP)
 - Monitor EKG secara kontinyu
 - 3) Syringe pump/ infus pump
 - Pastikan obat high-alert (inotropic, vasopressor) diberikan dengan pengawasan ketat
 - 4) Dialisis
 - Pasang akses vaskuler sesuai prosedur
 - Monitor hemodinamik pasien
 - 5) Feeding tube/ TPN
 - Tentukan rute nutrisi (enteral/parenteral)
 - Pantau risiko aspirasi pada NGT/OGT
- c. Monitoring pasien
 - 1) Ventilator : SPO₂, frekuensi, tekanan jalan napas, analisa gas darah
 - 2) Defibrilator : denyut jantung, irama EKG
 - 3) Pompa infus : kecepatan infus, tanda vital, efek samping obat
 - 4) Dialisis : balance cairan, elektrolit, tanda vital
 - 5) Nutrisi : status gizi, keseimbangan cairan, toleransi enteral/parenteral
- d. Melakukan pencegahan komplikasi
- e. Asuhan terintegrasi
 - 1) Dokter → menentukan indikasi, terapi, evaluasi klinis
 - 2) Perawat → monitoring tanda vital, pemeliharaan alat, tindakan keperawatan
 - 3) Apoteker → memastikan penggunaan obat high alert aman
 - 4) Nutrisi → memberikan nutrisi sesuai status pasien
 - 5) Fisioterapi → mobilisasi pasien ventilator untuk mencegah komplikasi imobilisasi
- f. Komunikasi dan edukasi
 - 1) Catatan medis lengkap
 - 2) Catatan observasi pasien
 - 3) Dokumentasi perawatan alat

g. Dokumentasi

1) Indikator mutu klinis

- Angka VAP pada pasien ventilator
- Angka infeksi terkait kateter
- ANgka survival pasien dengan ventilasi mekanik

2) Evaluasi harian → apakah pasien masih membutuhkan alat bantuan hidup atau bias dilakukan weaning

3) Audit klinis → dilakukan oleh Komite Medik & Komite PMKP

3.1.4 Pasien dengan penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan diabetes

- Melakukan assesmen komprehensif → medis, keperawatan, gizi, farmasi, rehabilitasi
- Melakukan asuhan kolaboratif → tim multidisiplin (dokter, perawat, farmasi, gizi, rehab medik)
- Keselamatan pasien
 - Monitoring ketat
 - Komunikasi SBAR
 - Edukasi keluarga
- Pencegahan komplikasi → bundle care (stroke unit, VAP bundle, foot care bundle)
- Dokumentasi → rekam medis lengkap ; diagnosis, terapi, evaluasi, edukasi
- Edukasi pasien dan keluarga → kepatuhan minum obat, diet, gaya hidup sehat

3.1.5 Pasien dengan risiko bunuh diri

a. Pengertian

- Bunuh diri adalah upaya yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk mengakhiri kehidupan.
- Faktor risiko bunuh diri adalah situasi yang memicu seseorang melakukan bunuh diri,

b. Penyakit yang memicu bunuh diri yaitu

- Penyakit kronis,
- Penyakit jiwa khususnya depresi,
- Riwayat percobaan bunuh diri,
- a. d) P engguna NAPZA & alcohol,
- Kegagalan,
- Pengalaman traumatis,
- Kesepian, kehilangan,
- Kemiskinan dan
- Sistem pendukung yang kurang.

c. Identifikasi risiko Bunuh Diri

- Skrining dan
- Pengkajian risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri
- Pengkajian lanjut,

d. Penanganan lebih lanjut.

Dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang terlatih & kompeten

e. Menerapkan SPO risiko bunuh diri dan melukai diri.

a. Pemantauan pasien yang berisiko bunuh diri

Contoh rawat inap umum dapat menerapkan persyaratan untuk petugas

yang ditugaskan (*one-on-one*), unit psikiatri dapat memilih untuk memantau setiap jam.

- g. Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh :
 - 1) variasi dalam lingkungan fisik dari area perawatan,
 - 2) rasio kepegawaian dan
 - 3) pendidikan staf, dan lain sebagainya.
- h. Tujuan pemantauan adalah untuk menjaga keselamatan pasien, di mana pun mereka dirawat di rumah sakit;
- i. Kepala bidang pelayanan melakukan pengkajian risiko dan berkolaborasi dengan staf klinis untuk mengidentifikasi dan menerapkan SPO yang paling sesuai dan tepat untuk setiap area perawatan klinis.
- j. Risiko lingkungan fisik untuk mengidentifikasi area dan fitur yang dapat digunakan untuk percobaan bunuh diri antaralain:
 - 1) Kamar pasien,
 - 2) kamar mandi pasien,
 - 3) Koridor, dan area
- k. Mengidentifikasi objek yang dapat digunakan untuk melukai diri sendiri
 - 1) Pelepasan titik jangkar/kaitan,
 - 2) Engsel pintu, dan
 - 3) Kait yang dapat digunakan untuk menggantung diri.
- l. Penatalaksanaan pasien dengan risiko bunuh diri
 - 1) Melakukan assesmen awal dan skrinning risiko
 - Dilakukan pada setiap pasien yang datang ke IGD, rawat jalan, maupun rawat inap
 - 2) Melakukan tindakan segera/ penanganan emergensi
 - Lakukan pertolongan medis segera (resusitasi bila ada cedera, overdosis, trauma).
 - Amankan lingkungan dari benda berbahaya (pisau, obat-obatan, tali, kaca).
 - Pasien ditempatkan di area yang mudah dipantau (ruang pengawasan intensif/isolasi psikiatri).
 - Monitoring ketat tanda vital & status mental
 - 3) Melakukan asuhan medis dan psikiatri
 - Konsultasi dan kolaborasi dengan dokter spesialis kejiwaan (psikiater).
 - Tatalaksana : farmakoterapi, Psikoterapi, manajemen komorbid
 - Bila risiko sangat tinggi → rujuk ke RS Jiwa
 - 4) Melakukan asuhan keperawatan
 - Observasi pasien minimal 1:1 (satu perawat satu pasien) bila risiko tinggi.
 - Catat perubahan perilaku (gelisah, menarik diri, menyampaikan keinginan mati).
 - Gunakan komunikasi terapeutik: mendengarkan tanpa menghakimi, memberi empati.
 - Edukasi keluarga untuk ikut mendampingi pasien
 - 5) Asuhan terintegrasi tim multidisiplin
 - Kolaborasi: Dokter, psikiater, perawat, farmasis, psikolog klinis, pekerja sosial, rohaniawan, keluarga pasien.
 - 6) Pencegahan komplikasi & keselamatan pasien
 - Lingkungan aman: hilangkan akses ke senjata tajam, tali, obat berlebih.
 - Pengawasan berkelanjutan: CCTV/observasi langsung.
 - Dokumentasi lengkap: hasil asesmen risiko, intervensi, respon pasien.
 - Edukasi keluarga: mengenali tanda peringatan, memastikan kepatuhan obat, dukungan emosional

- 7) Persiapan pulang dan tindak lanjut
 - Evaluasi kondisi pasien, pastikan risiko menurun sebelum pulang.
 - Buat rencana follow up:
 - Kontrol ke poliklinik jiwa/psikiatri.
 - Dukungan psikososial (komunitas, support group).
 - Home care bila perlu.
 - Berikan nomor darurat (hotline bunuh diri, nomor IGD rumah sakit).
- m. Alur identifikasi pasien risiko bunuh diri
 - 1) Penerimaan pasien
 - 2) Skrining risiko bunuh diri
 - 3) Menentukan hasil skrining
 - 4) Tindak lanjut berdasarkan risiko
 - 5) Dokumentasi
 - 6) Edukasi & keterlibatan keluarga
 - 7) Monitoring & evaluasi

1.1.6 Risiko tambahan pada pasien risiko tinggi

- a. Risiko jatuh
 - 1) Pasien usia lanjut, naak – anak, pasien pasca operasi, pasien dengan gangguan keseimbangan
 - 2) Standar : assesmen risiko jatuh dilakukan sejak awal
- b. Risiko nyeri tidak terkontrol
 - 1) Pasien dengan penyakit kronis, kanker, pasca operasi
 - 2) Standar : pengkajian nyeri rutin
- c. Risiko malnutrisi
 - 1) Pasien anak, lansia, pasien dengan penyakit kronis/ kritis
 - 2) Standar : skrining gizi
- d. Risiko gangguan psikologis/ emosional
 - 1) Pasien dengan gangguan jiwa, pasien terminal, pasien isolasi
 - 2) Standar : isolasi, kewaspadaan standar dan kewaspadaan spiritual
- e. Risiko penularan infeksi
 - 1) Pasien dengan TB, HIV/AIDS, Covid 19, Hepatitis, dsb
 - 2) Standar : isolasi, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi
- f. Risiko keselamatan obat
 - 1) Pasien yang menggunakan obat High Alert (insulin, heparin, dll)
 - 2) Standar : double check, label, pembatasan penyimpanan
- g. Risiko komunikasi dan edukasi
 - 1) Pasien dengan keterbatasan bahasa, pendidikan rendah, atau gangguan sensori
 - 2) Standar : gunakan komunikasi efektif, *informed consent* jelas.

3.2 Pelayanan Risiko Tinggi

3.2.1 Kriteria pelayanan risiko tinggi meliputi

- 1) Pelayanan pasien dengan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa;
- 2) Pelayanan pada pasien dengan “*immuno-suppressed*”;
- 3) Pelayanan pada pasien yang mendapatkan pelayanan dialisis;
- 4) Pelayanan pada pasien yang *direstrain*;
- 5) Pelayanan pada pasien yang menerima kemoterapi;
- 6) Pelayanan pasien paliatif;
- 7) Pelayanan pada pasien yang menerima radioterapi;
- 8) Pelayanan terapi hiperbarik

- 9) Pelayanan radiologi intervensi;
- 10) Pelayanan pada populasi pasien rentan, pasien lanjut usia (geriatri) misalnya anak – anak dan pasien berisiko tindak kekerasan atau diterlantarkan.
- 11) Pelayanan pada pasien yang dilakukan tindakan khusus
 - f) Pasien luka decubitus
 - g) Cedera neurologis
 - h) Infeksi penggunaan ventilator
 - i) Infeksi saluran/ slang central
 - j) Pasien jatuh

3.2.2 Strategi manajemen pelayanan risiko tinggi

- a. Pencegahan
 - 1) Skrining dan assesmen risiko sejak pasien masuk
 - 2) Penerapan sasaran keselamatan pasien
 - 3) Standar informed consent sebelum tindakan invasive/ berisiko.
 - 4) Protokol kewaspadaan universal (PPI, APD, Higiene)
- b. Pelaksanaan
 - 1) Pelayanan dilakukan oleh tenaga Kesehatan kompeten dan terakreditasi
 - 2) Penggunaan clinical pathway, panduan praktik klinis (PPK) dan SPO.
 - 3) Penerapan checklist
 - 4) Monitoring ketat tanda vital dan respon pasien
 - 5) Double check obat risiko tinggi
- c. Pengendalian dan monitoring
 - 1) Supervisi oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP)
 - 2) Audit medik dan farmasi klinik untuk kasus risiko tinggi
 - 3) Pelaporan insiden keselamatan pasien
 - 4) Review mortalitas dan morbiditas
- d. Evaluasi dan peningkatan
 - 1) Evaluasi rutin melalui Komite PMKP
 - 2) Analisis akar masalah (RCA) pada insiden sentinel
 - 3) Implementasi rekomendasi perbaikan system
 - 4) Pelatihan berkala staf mengenai pelayanan risiko tinggi
- e. Dokumentasi
 - 1) Assesmen risiko tinggi dicatat dalam rekam medis
 - 2) Checklist, formulir persetujuan tindakan dan monitoring harian wajib terdokumentasi
 - 3) Laporan insiden dan tindak lanjut tercatat dalam system manajemen risiko rumah sakit.

3.3 Pelayanan Geriatri

3.3.1 Tingkat jenis pelayanan geriatri:

- a. Tingkat sederhana (rawat jalan dan home care)
- b. Tingkat lengkap (rawat jalan, rawat inap akut dan *home care*) disinilah kemampuan RSPH untuk pelayanan Geriatri
- c. Tingkat sempurna (rawat jalan, rawat inap akut dan *home care* klinik asuhan siang)
- d. Tingkat paripurna (rawat jalan, klinik asuhan siang, rawat inap akut, rawat inap kronis, rawat inap *psychogeriatric*, penitipan pasien *Respite care* dan *home*

care)

3.3.2 Tujuan

- a. Memberikan pelayanan Kesehatan komprehensif dan berkesinambungan kepada pasien geriatric
- b. Meningkatkan kualitas hidup pasien lanjut usia
- c. Mencegah komplikasi, kecacatan, dan ketergantungan.
- d. Menjamin keselamatan pasien sesuai standar akreditasi
- e. Mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangan.

3.3.3 Prinsip pelayanan geriatri

- a. Komprehensif → mencakup aspek media, psikologis, fungsional, social dan spiritual
- b. Multidisiplin dan terintegrasi → melibatkan dokter, perawat, fisioterapis, apoteker, ahli gizi, psikologis, dan profesi lain.
- c. Individualisasi → pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan unik tiap pasien.
- d. Berorientasi pada pasien dan keluarga → melibatkan pasien dan keluarga dalam perencanaan asuhan.
- e. Keselamatan pasien → mengutamakan prinsip *patient safety*
- f. Kontinuitas layanan → adanya koordinasi antar unit dan tindak lanjut pasca perawatan.

3.3.4 Struktur Tim Pelayanan Geriatri

- a. Dokter spesialis penyakit dalam / DPJP
- b. Dokter spesialis terkait (neurologi, psikiatri, rehabilitasi medik, dll)
- c. Perawat geriatric
- d. Apoteker
- e. Ahli gizi
- f. Fisioterapis dan nakes yang lain

3.3.5 Standar Pelayanan

- a. Rawat jalan
 - 1) Skrining komprehensif
 - 2) Konsultasi multidisiplin
 - 3) Edukasi pasien dan keluarga
 - 4) Program promotive-preventif
- b. Rawat Inap
 - 1) Asuhan medis dan keperawatan berbasis CGA
 - 2) Perencanaan pulang (*discharge planning*)
 - 3) Rehabilitasi medik
- c. IGD
 - 1) Penanganan cepat, aman dan sesuai kondisi lansia
 - 2) Skrining risiko jatuh, delirium, malnutrisi dan penyakit kronis
 - 3) Triase sesuai standar akreditasi dan kebutuhan khusus lansia
- d. Penunjang
 - 1) Farmasi → pelayanan farmasi klinik dengan perhatian khusus pada polifarmasi.
 - 2) Gizi → assesmen gizi lanjut usia dan intervensi nutrisi individual
 - 3) Rehabilitasi medik → Latihan fungsional, pencegahan jatuh

3.3.6 Alur Pelayanan Geriatri

- a. Pasien lansia datang ke RS (IGD/Rawat jalan/Rawat Inap)

- b. Dilakukan skrinning geriatric (status fungsional, kognitif, nutrisi, social, risiko jatuh)
- c. Asesmen komprehensif oleh tim geriatric
- d. Penyusunan rencana asuhan terintegrasi
- e. Pelaksanaan asuhan oleh tim multidisiplin
- f. Monitoring, evaluasi dan koordinasi layanan
- g. Edukasi dan keterlibatan keluarga
- h. Discharge planning dan tindak lanjut

3.3.7 Keselamatan pasien dalam pelayanan geriatri

- b. Identifikasi pasien dengan benar
- c. Pencegahan jatuh di ruang perawatan
- d. Pencegahan infeksi nosocomial
- e. Pengelolaan obat high-alert dan polifarmasi
- f. Edukasi pasien dan keluarga terkait terapi dan pencegahan komplikasi.

1.3.8. Program PKRS Pada Pelayanan Geriatri

Pembinaan Komunitas Warga Lanjut Usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based Community Geriatric Service*).

A. Ruang lingkup kegiatan PKRS Geriatri

- a. Promotif
 - 1) Edukasi tentang gizi seimbang pada lansia
 - 2) Penyuluhan aktivitas fisik sesuai kemampuan
 - 3) Edukasi Kesehatan mental dan pencegahan depresi
 - 4) Edukasi tentang pengelolaan penyakit kronis
 - 5) Informasi hak dan kewajiban pasien geriatri
 - 6) Pemberian contoh menu makanan sehat/PMT promotive
 - 7) Studi wisata
- b. Preventif
 - 1) Senam Geriatri
 - 2) Edukasi pencegahan jatuh
 - 3) Pencegahan decubitus
 - 4) Edukasi penggunaan obat yang aman
 - 5) Skrinning rutin (status gizi, fungsi kognitif, risiko depresi)
 - 6) KIE PHBS
 - 7) Kegiatan peningkatan keterampilan Geriatri
- c. Kuratif dan rehabilitative
 - 1) Edukasi manajemen perawatan diri
 - 2) Edukasi keluarga terkait perawatan harian lansia
 - 3) Dukungan psikososial dan spiritual
 - 4) Rehabilitasi melalui Latihan fisik sederhana dan terapi okupasi
 - 5) Kegiatan keagamaan (pengajian, menjadi Tim Binroh)
 - 6) Hipnoterapi

B. Strategi pelaksanaan

- a. Metode ; penyuluhan, konseling, diskusi kelompok, media cetak, media elektronik brosur, leaflet, video, dan lain-lainnya,
- b. Pelaksana : Tim PKRS bekerjasama dengan Tim Geriatri (dokter, perawat, farmasi, gizi, fisioterapi)

- c. Waktu
 - 1) Rawat jalan → setiap kunjungan
 - 2) Rawat inap → minimal 1 kali perawatan
 - 3) Kegiatan Pembinaan komunitas berbasis RS → sesuai program RS

C. Indikator program

- a. Proses
 - 1) Jumlah kegiatan edukasi geriatric yang dilaksanakan
 - 2) Persentase pasien dan keluarga geriatri yang mendapat edukasi > 80%
- b. Hasil
 - 1) Peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga
 - 2) Penurunan angka kejadian jatuh/ decubitus pada pasien geriatric
 - 3) Peningkatan kepatuhan minum obat pasien geriatric
 - 4) Peningkatan kepuasan pasien dan keluarga
- c. Monev dan Pembuatan laporan secara berkala

3.4 Kesehatan Jiwa

a. Pengertian :

- 1) Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
- 2) Orang berisiko gangguan jiwa
Orang yang berisiko gangguan jiwa adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
- 3) ODGJ :
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
- 4) ODMK :
Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)

b. HPK Gangguan Jiwa

- 1) Rumah sakit dalam melakukan penanganan ODMK dan ODGJ perlu menghargai hak asasi manusia.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan jiwa di Rumah Sakit yang berkualitas dan menghargai hak-hak asasi orang dengan gangguan jiwa yang meliputi
 - (1) Penghargaan (*to respect*),
 - (2) Pemenuhan perawatan (*to fulfill*), dan
 - (3) Perlindungan (*to protect*).
- 3) Hak-hak pengguna pelayanan kesehatan jiwa dalam mendapatkan perawatan yang berkualitas, meliputi dan tidak terbatas pada:

- (1) Penghargaan terhadap kebutuhan pelayanan fisik maupun psikologis;
- (2) Kebebasan untuk berkomunikasi; dan
- (3) Hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sampai pada sarana prasarana, makanan dan pakaian

3.5 Early Warning System (EWS)

3.5.1 Pelaksanaan ESW pada pasien dewasa

- a. Parameter EWS
 - 1) Frekuensi napas (RR)
 - 2) Saturasi O2
 - 3) Tekanan darah sistolik (TD)
 - 4) Nadi (HR)
 - 5) Kesadaran (AVPU)
- b. Skoring EWS

Tabel 3.5.1.1 Skoring EWS pada Pasien Dewasa

Parameter	3	2	1	0	1
RR (x/menit)	≤ 8		9 – 11	12 – 20	21 – 24
Saturasi O2 (%)	≤ 91	92 – 93	94 – 95	≥ 96	
TS Sistolik (mmHg)	≤ 70	71 – 80	81 – 100	101 – 199	
Nadi (x/menit)	≤ 40	41 - 50	51 – 100	101 – 110	111 – 129
Kesadaran				A	V
Suhu (°C)	≤ 35		35,1 - 36	36,1 - 38	38,1 - 39

- c. Interpretasi dan tindak lanjut
 - Skor 0-2 → observasi rutin setiap 6-8 jam
 - Skor 3 (pada satu parameter) → ulangi pemeriksaan dalam 30 menit, laporkan ke dokter penanggung jawab
 - Skor 4-5 → tingkatkan frekuensi monitoring (tiap 1-2 jam), konsultasi dokter jaga/ DPJP.
 - Skor ≥ 6 atau kondisi memburuk cepat → aktifkan Code Blue
- d. Alur pelaksanaan
 - 1. Pengukuran tanda vital dilakukan oleh perawat minimal setiap shift atau sesuai kondisi klinis.
 - 2. Hitung skor ESW setelah pengukuran
 - 3. Dokumentasikan skor di lembar observasi ESW pada rekam medis
 - 4. Lakukan tindak lanjut sesuai skor
 - 5. Laporkan dengan komunikasi SBAR
 - 6. Evaluasi dan catat kembali perkembangan setelah tindakan dilakukan.

3.5.2 Pelaksanaan EWS pada pasien anak

- a. Parameter EWS
 - 1. Pernafasan (frekuensi, upaya napas, penggunaan O2)
 - 2. Sirkulasi (frekuensi nadi, perfusi, tekanan darah)
 - 3. Kesadaran (AVPU)
 - 4. Perilaku/ aktivitas (gelisah, rewel, lemah, tidak responsive)
 - 5. Warna kulit (pucat, sianosis, normal)
- b. Skoring PEWS

Tabel 3.5.2.1 Skoring PEWS

Parameter	0 (normal)	1 (ringan)	2 (sedang)	3 (berat)
-----------	------------	------------	------------	-----------

Respirasi	RR normal sesuai usia	RR ↑ 10 dari normal, napas cepat	RR ↑ 20 dari normal, retraksi ringan	RR abnormal berat, retraksi berat, apnea
Oksigenasi	RA, SPO ₂ ≥ 95%	SPO ₂ 90-94 % tanpa O ₂	SPO ₂ < 90 % tanpa O ₂ atau butuh O ₂	SPO ₂ < 85% meski O ₂
Nadi	Nomral sesuai usia	Sedikit ↑/↓ dari normal	Tachy/ brady sedang	Sangat abnormal/ tidak teraba
Kesadaran (AVPU)	A (sadar penuh)	V (respon suara)	P (respon nyeri)	U (tidak respons)
Perilaku/ aktivitas	Normal	Rewel, cemas	Letargi, lemah	Tidak respons, apatis
Warna kulit	Normal	Pucat ringan	Pucat/ sianosis perifer	Sianosis sentral

c. Interpretasi skor dan tindak lanjut

- Skor 0-2 → observasi rutin sesuai standar (6-8 jam)
- Skor 3-4 → ulangi pemeriksaan 30 menit – 1 jam, laporkan ke dokter jaga/DPJP
- Skor 5-6 → monitoring ketat tiap 30 menit, konsultasi segera ke DPJP
- Skor ≥ 7 atau perburukan cepat → aktifkan Code blue

d. Alur pelaksanaan

1. Pengukuran tanda vital (RR, HR, SPO₂, suhu, kesadaran, warna kulit) minimal setiap shift.
2. Hitung skor PEWS oleh perawat setelah pemeriksaan
3. Dokumentasi skor di formulir PESW
4. Tindak lanjut sesuai skor dan alur eskalasi klinis
5. Laporkan kondisi pasien ke dokter menggunakan SBAR
6. Evaluasi ulang setelah intervensi

3.5.3 Edukasi pasien dan keluarga

- a. Edukasi keluarga untuk mengenali tanda bahaya (sesak, kejang, lemas mendadak, tidak responsive)
- b. Melibatkan keluarga dalam pemantauan perubahan perilaku anak
- c. Menginformasikan prosedur pelaporan cepat ke perawat jika ada perubahan.

3.6 Resusitasi

Pelayanan resusitasi diartikan sebagai intervensi klinis pada pasien yang mengalami kejadian mengancam hidupnya seperti henti jantung atau paru.

3.6.1 Prinsip resusitasi

- a. Cepat → deteksi dini henti jantung/napas
- b. Tepat → lakukan sesuai algoritma standar
- c. Terintegrasi → melibatkan Tim Resusitasi/*Code Blue*
- d. Aman → memperhatikan keselamatan pasien dan petugas.

3.6.2 Identifikasi pasien gawat darurat

Tanda henti napas/jantung

- a. Tidak responsive

- b. Tidak bernapas atau hanya gasping
- c. Tidak ada nadi besar (karotis/femoralis)
- d. Saturasi < 85% meskipun dengan O₂

3.6.3 Algoritma Resusitasi

- a. Resusitasi dasar (BLS) – Dewasa dan anak
 - 1) Pastikan keselamatan petugas dan pasien
 - 2) Cek respon pasien
 - 3) Aktifkan Code Blue
 - 4) Cek napas dan nadi (≤ 10 detik)
 - 5) Jika tidak ada → segera lakukan RJP
 - 6) Kompresi dada
 - 7) Dewasa : kedalaman 5-6 cm, kecepatan 100-120 x/menit
 - 8) Anak ; 1/3 diameter dada (4 cm bayi, 5 cm anak)
 - 9) Ventilasi
 - 10) Gunakan Defibrilator bila perlu
- b. Resusitasi Lanjut (ACLS/PALS)
 - 1) Airway → pastikan jalan napas terbuka, intubasi bila perlu
 - 2) Breathing → ventilasi dengan oksigen 100%, monitoring SPO₂
 - 3) Circulation → kompresi dada – akses IV
 - 4) Defibrilasi sesuai ritme (VF/pulseless VT)
 - 5) Obat – obatan ;
 - 6) Adrenalin 1 mg IV/IO tiap 3-5 menit
 - 7) Amiodaron untuk VF/VT refraktor
 - 8) Evaluasi ritme tiap 2 menit
 - 9) Post – resusitasi care (ICU)

3.6.4. Prosedur Aktivasi Tim Resusitasi

- a. Deteksi awal
 - 1) Temukan pasien tidak responsif, tidak bernapas/napas abnormal (gaspings) atau tidak ada nadi.
 - 2) Segera minta bantuan orang terdekat
 - 3) Lakukan RJP dasar segera (kompresi dada) sambil aktivasi lain.
- b. Aktivasi Tim Code Blue
 - 1) Aktifkan Code Blue dengan menelpon nomor sentral/CSO (105)
 - 2) Operator/telp sentral segera mengumumkan “Code Blue” – Lokasi (unit/ruangan)
 - 3) Sistem alarm aktif → Tim Code Blue bergerak ke lokasi
- c. Respon Tim Code Blue
 - 1) Waktu respon maksimal ≤ 5 menit sejak aktivasi.
 - 2) Tim membawa troli emergensi.
 - 3) Jika ROSC (*Return of Spontaneous Circulation*) tercapai → pasien dipindahkan ke ICU
 - 4) Jika tidak berhasil → dokumentasikan waktu henti, durasi resusitasi dan hasil akhir
- d. Dokumentasi
 - 1) Semua kejadian resusitasi dicatat dalam Form Code Blue
 - a) Identitas pasien
 - b) Waktu henti dan waktu aktivasi
 - c) Waktu tim tiba
 - d) Prosedur yang dilakukan
 - e) Obat dan dosis

- f) Hasil akhir (ROSC/Exitus)
- 2) Evaluasi dilakukan oleh Komite PMKP

3.7 Pelayanan Darah dan Produk Darah

3.7.1 Proses Pelayanan Darah

- a. Permintaan darah
 - 1) Dokter mengisi formulir permintaan tranfusi darah lengkap (identitas pasien, diagnosis, indikasi, jenis produk, jumlah)
 - 2) Dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium (HB, Hematokrit, Trombosit sesuai indikasi)
- b. Penyediaan darah
BDRS melakukan pemeriksaan :
 - 1) Golongan darah ABO dan Rhesus
 - 2) Uji saring penyakit infeksi menular lewat tranfusi (HIV, Hepatitis B/C, Sifilis)
 - 3) Crossmatch (uji cocok serasi)
- c. Distribusi dan penyimpanan
 - 1) Produk darah disimpan sesuai standar suhu
 - (1) PRC : 2 – 6°C
 - (2) Trombosit ; 20 – 24°C dengan agitator
 - (3) Plasma ; 30°C
 - 2) Distribusi menggunakan cool box standar dengan suhu terjaga
- d. Pemberian Tranfusi
 - 1) Verifikasi identitas pasien
 - 2) Verifikasi kesesuaian golongan darah dengan kantong darah
 - 3) Pasang jalur tranfusi dengan filter standar
 - 4) Observasi tanda vital ; sebelum tranfusi, 15 menit pertama, kemudian tiap 30 menit, dan setelah selesai.
 - 5) Catat semua proses di rekam medis dan formulir monitoring tranfusi.
- e. Monitoring dan penatalaksanaan reaksi tranfusi
Jika ada reaksi tranfusi (demam, menggigil, sesak, hipotensi, nyeri dada)
 - 1) Hentikan tranfusi segera
 - 2) Pertahankan akses intravena dengan NaCl 0,09%
 - 3) Laporkan ke dokter dan BDRS
 - 4) Catat dalam formulir reaksi tranfusi
 - 5) Investigasi dilakukan oleh BDRS

3.7.2 Peran dan tanggung jawab

- 1) Dokter → menegaskan indikasi, menentukan jenis/jumlah darah, menjelaskan risiko, meminta *informed consent*, dan melakukan evaluasi
- 2) Perawat → melaksanakan tranfusi, monitoring pasien, mendeteksi dini reaksi tranfusi, dokumentasi
- 3) Analis BDRS → melakukan pemeriksaan serologi, uji kompatibilitas dan menyiapkan darah
- 4) Manajemen RS → memastikan sarana (*cold chain system*, formulir, SDM terlatih dan berwenang)

BAB IV

PEMBERIAN MAKANAN DAN TERAPI NUTRISI

Rumah sakit memberikan makanan untuk pasien rawat inap dan terapi nutrisi terintegrasi untuk pasien dengan risiko nutrisi

4.1 Proses Pelayanan dan Pengkajian Gizi

4.1.1 Skrining Gizi

- a. Dilakukan ≤ 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit oleh perawat menggunakan instrument baku
- b. Hasil skrining :
 - Risiko gizi rendah $\rightarrow$ diberikan pelayanan gizi dasar.
 - Risiko gizi sedang/ tinggi $\rightarrow$ dirujuk ke ahli gizi untuk *assesmen* gizi lanjut.

4.1.2 Assesmen Gizi

- e. *Assesmen* (pengkajian gizi)
 - 1) Data antropometri (BB, TB, IMT, lingkar lengan, lingkar kepala anak, dll)
 - 2) Data biokimia/ laboratorium (Hb, albumin, gula darah, profil lipid, dll)
 - 3) Data klinis (riwayat penyakit, tanda klinis malnutrisi, obat – obatan)
 - 4) Data dietetic (riwayat makan, pola makan, asupan makanan)
 - 5) Data social-ekonomi dan psikologis (dukungan keluarga, akses makanan)
- f. Diagnosis gizi
 - Ditulisd lam format PES
- g. Intervensi gizi
 - 1) Penentuan kebutuhan energi, protein, cairan dan zat gizi sesuai kondisi klinis
 - 2) Perencanaan diet (oral, enteral, parenteral)
 - 3) Modifikasi tekstur/ jenis makanan
 - 4) Konseling gizi pasien dan keluarga
 - 5) Edukasi gizi sesuai penyakit (DM, Gagal ginjal, jantung, dll)
- h. Monitoring dan evaluasi
 - 1) Evaluasi asupan, status gizi dan kepatuhan diet secara berkala
 - 2) Penyesuaian intervensi sesuai perkembangan pasien
 - 3) Hasil monev didokumentasikan dalam rekam medis.
- i. Dokumentasi
 - 1) Semua tahapan skrining, assesmen, diagnosis, intervensi, monitoring dan evaluasi gizi wajib dicatat dalam rekam medis pasien.
 - 2) Menggunakan format PAGT
 - 3) Dokumentasi diverifikasi oleh ahli gizi.
- j. Koordinasi interdisiplin
 - 1) Ahli gizi bekerjasama dengan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat, farmasi dan tim lain dalam Tim Asuhan Pasien
 - 2) Setiap intervensi gizi penting dikomunikasikan dalam rounding medis atau diskusi klinis.

4.2 Prosedur Penentuan Kebutuhan Gizi

- a. Persiapan
 - 1) Identifikasi data pasien dari rekam medis (nama, umur, jenis kelamin, diagnosis, kondisi klinis)
 - 2) Siapkan alat ukur antropometri
 - 3) Siapkan format assesmen gizi untuk pencatatan.
- b. Pengumpulan data
 - 1) Antropometri
 - 2) Berat badan actual/BB idela, tinggi badan, IMT, LILA, lingkar kepala (anak)
 - 3) Perubahan berat badan dalam 1-6 bulan terakhir
 - 4) Biokimia/ laboratorium : HB, albumin, gula darah, elektrolit, profil lipid, dll
 - 5) Klinis : diagnosis medis, status hidrasi, fungsi oragan (ginjal, hati, jantung)
 - 6) Dietetik ; riwayat makan, pola makan, asupan 24 jam terakhir
 - 7) Faktor lain : usia, aktivitas fisik, status psikososial, obat – obatan.

4.3 Jenis Terapi Nutrisi

- a. Makanan oral standar → Pasien mampu makan per oral, disesuaikan tekstur (biasa, lunak, cair)
- b. Diet khusus → rendah garam, tinggi protein, rendah purin, diet DM, diet gagal ginjal, dll
- c. Nutrisi enteral → jika pasien tidak mampu mencukupi kebutuhan oral tetapi fungsi GI masih baik (dengan NGT, PEG)
- d. Nutrisi parenteral → bila saluran cerna tidak berfungsi/ kontra indikasi (melalui vena sentral/perifer)

4.4 Distribusi Makanan

4.4.1 Alur distribusi makanan

- a. Persiapan
 - 1) Instalasi gizi menyiapkan makanan sesuai dengan menu diet harian yang telah diverifikasi ahli gizi.
 - 2) Pengemasan makanan menggunakan wadah tertutup, higienis, diberi label identitas pasien.
 - 3) Label memuat : nama pasien, nomor rekam medis, ruangan, jenis diet, waktu makan.
- b. Distribusi ke unit
 - 1) Makanan diantar oleh petugas distribusi
 - 2) Menggunakan troli makanan khusus, bersih dan dipisahkan antara makanan pasien, makanan staf, serta sisa makanan.
 - 3) Waktu distribusi sesuai jadwal.
- c. Serah terima di unit perawatan
Makanan diberikan langsung ke pasien atau keluarga pendamping pasien.
- d. Pencatatan dan dokumentasi
 - 1) Instalasi gizi mencatat jumlah makanan yang didistribusikan
 - 2) Sisa makanan pasien dicatat untuk evaluasi asupan.

4.4.2 Pengendalian mutu dan keamanan

- a. Suhu makanan diperiksa : makanan panas $\geq 60^{\circ}\text{C}$, makanan dingin $\leq 10^{\circ}\text{C}$ saat distribusi
- b. Pengendalian *cross contamination* : makanan diet khusus dipisahkan

- c. Petugas distribusi wajib menggunakan APD
- d. Troli distribusi dibersihkan setiap selesai digunakan
- e. Audit distribusi dilakukan rutin oleh tim gizi dan mutu

4.4.3 Monitoring dan evaluasi

- a. Dilakukan melalui food tasting sebelum distribusi
- b. Evaluasi keterlambatan distribusi, kesalahan diet, keluhan pasien
- c. Analisis data sisa makanan untuk menilai penerimaan diet
- d. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat mutu instalasi gizi.

4.5 Makanan dari luar rumah sakit

4.5.1 Ketentuan Umum

- a. Pasien dilarang menerima makanan dari luar, jika :
 - 1) Sedang menjalani diet khusus/ terapeutik (Renal, DM, Jantung, NGT, alergi makanan, dll)
 - 2) Dalam kondisi risiko tinggi infeksi (pasien imunokompromais, pasca operasi besar, ICU/NICU)
 - 3) Makanan tidak memenuhi standar keamanan pangan (basi, tidak higienis, kadaluarsa)
- b. Makanan dari luar diperbolehkan dengan persetujuan dokter/ ahli gizi/ perawat jika :
 - 1) Tidak bertentangan dengan diet medis pasien
 - 2) Dibawa dalam kondisi higienis, terbungkus baik, dan layak konsumsi.

4.5.2 Prosedur manajemen makanan dari luar

- a. Penerimaan
 - 1) Keluarga menyerahkan makanan kepada petugas (perawat ruangan)
 - 2) Perawat/ ahli gizi melakukan pemeriksaan :
 - Label/ keterangan pasien
 - Jenis makanan dan kesesuaian dengan diet pasien
 - Kondisi fisik makanan (warna, bau, suhu, kebersihan)
- b. Verifikasi
 - 1) Jika sesuai diet pasien → boleh diberikan dengan catatan.
 - 2) Jika tidak sesuai diet → ditolak dengan edukasi kepada keluarga
 - 3) Jika meragukan (potensi infeksi pangan) → dimusnahkan sesuai prosedur limbah makanan
- c. Edukasi

Perawat/ ahli gizi memberikan edukasi kepada keluarga mengenai :

 - 1) Diet medis pasien dan makanan yang harus dihindari
 - 2) Risiko makanan yang tidak higienis (keracunan, infeksi)
 - 3) Pentingnya kepatuhan terhadap program gizi rumah sakit.

4.6 Edukasi Gizi Pasien

a. Prinsip edukasi

- 1) Edukasi gizi diberikan berdasarkan assesmen gizi dan diet yang ditetapkan DPJP
- 2) Edukasi dilakukan secara personalized sesuai kondisi pasien
- 3) Edukasi dapat diberikan kepada pasien, keluarga atau pendamping
- 4) Materi edukasi disampaikan dengan bahasa sederhana, menggunakan media bantu (leaflet, poster, video) bila diperlukan
- 5) Dilakukan pencatatan dan dokumentasi dalam rekam medis pasien

-
- b. Metode edukasi
 - 1) Individu : tatap muka langsung dengan pasien/ keluarga
 - 2) Kelompok : edukasi bersama untuk pasien dengan masalah gizi yang sama
 - 3) Medis cetak/ digital : leaflet, booklet, video edukasi
 - c. Materi edukasi gizi

Materi disesuaikan dengan kondisi pasien, meliputi :

 - 1) Gizi seimbang : konsep isi piringku, kebutuhan harian
 - (1) Diet medis spesifik
 - (2) DM : pengaturan karbohidrat, gula, jadwal makan
 - (3) Ginjal : pembatasan natrium, kalium, protein
 - (4) Jantung : rendah garam, rendah lemak jenuh
 - (5) Obesitas : pengaturan kalori, olah raga
 - 2) Cara konsumsi obat dan makanan
 - 3) Keamanan pangan : memilih makanan higienis, cara penyimpanan
 - 4) Perilaku hidup sehat : aktivitas fisik, hidrasi cukup, pola tidur
 - d. Proses edukasi
 - 1) Identifikasi kebutuhan edukasi berdasarkan assesmen gizi
 - 2) Menetapkan tujuan edukasi bersama pasien/keluarga
 - 3) Pelaksanaan edukasi oleh ahli gizi/ perawat terlatih.
 - 4) Evaluasi pemahaman pasien dengan metode *teach back* (pasien mengulang kembali inti edukasi).
 - 5) *Follow up* bila pasien membutuhkan edukasi lanjutan (misalnya pasien rawat jalan)

BAB V

PENGELOLAAN NYERI

5.1 Skrinning Nyeri

5.1.1 Skrining, pengkajian, dan tata laksana untuk mengatasi rasa nyeri, yang terdiri dari:

- 1) Identifikasi pasien dengan rasa nyeri pada pengkajian awal dan pengkajian ulang.
- 2) Memberi informasi kepada pasien bahwa rasa nyeri dapat merupakan akibat dari terapi, prosedur, atau pemeriksaan.
- 3) Memberikan tata laksana untuk mengatasi rasa nyeri, terlepas dari mana nyeri berasal, sesuai dengan regulasi rumah sakit.
- 4) Melakukan komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pengelolaan nyeri sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai yang dianut.
- 5) Memberikan edukasi kepada seluruh PPA mengenai pengkajian dan pengelolaan nyeri.

5.1.2 Skrinning nyeri pada pasien dewasa sadar

a. Instrumen Skrinning

Instrumen yang digunakan pada pasien dewasa sadar :

- 1) Numeric Rating Scale (NRS)
- 2) Visual Analog Scale (VAS)
- 3) Verbal Descriptor Scale (VDS)

b. Prosedur skrinning nyeri

1) Persiapan

- Lakukan komunikasi terapeutik dan jelaskan tujuan penilaian nyeri
- Siapkan instrument sesuai standar

2) Pelaksanaan

- Tanyakan langsung
 - “Apakah Bapak/Ibu merasakan nyeri sekarang?”
 - Jika ya, lanjutkan dengan skala nyeri
- Gunakan NRS sebagai standar utama.
 - “Kalau) artinya tidak nyeri, dan 10 artinya nyeri paling hebat yang pernah dirasakan, sekarang berapa Tingkat nyeri Bapak/Ibu?”
- Catat skor nyeri, Lokasi, karakter, durasi dan factor pencetus/ Pereda.

3) Interpretasi hasil

- 0: tidak ada nyeri
- 1-3 : nyeri ringan (biasanya masih bisa beraktivitas)
- 4-6 : nyeri sedang (mengganggu aktivitas)
- 7-10 : nyeri berat (mengganggu total, butuh intervensi segera)

4) Tindak lanjut

- Skor $\geq 4 \rightarrow$ wajib dilaporkan ke DPJP/ perawat penanggung jawab untuk assesmen nyeri lebih lanjut dan intervensi

- Setelah pemberian intervensi (farmakologis/ non farmakologis), evaluasi ulang nyeri dalam 30 – 60 menit
- c. Dokumentasi
 1. Catat skor nyeri dalam rekam medis
 2. Catat tindakan intervensi dan evaluasi hasilnya
- d. Monitoring
 1. Pasien rawat inap : skrinning nyeri minimal setiap shift
 2. Pasien pasca operasi ; sesuai protocol monitoring pasca bedah (setiap 1-2 jam awal)
 3. Pasien rawat jalan : dilakukan pada setiap kunjungan

5.1.3 Skrinning nyeri pada pasien anak

1. Instrumen skrinning nyeri anak
 - 1) Bayi - <1 tahun
 - NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) → menilai ekspresi wajah, menangis, pernapasan, lengan, kaki, kesadaran.
 - FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)
 - 2) Anak usia 1-3 tahun (toddler)
 - 3) FLACC Scale
 - 4) Observasi perilaku.
 - 5) Anak usia 3-7 tahun (preschool)
 - 6) Wong-Baker FACES Pain Rating Scale
 - 7) Dapat menunjuk wajah sesuai nyeri dirasakan.
 - 8) Anak usia 7-12 tahun (school age)
 - 9) Numeric Rating Scale (NRS 0-10)
 - 10) Wong Baker FACES (jika lebih nyaman)
 - 11) Anak ≥ 12 tahun (remaja)
 - NRS 0-10
 - Visual Analog Scale (VAS)
2. Prosedur skrinning nyeri
 - 1) Identifikasi
 - Tanyakan nyeri pada semua pasien anak (atau observasi jika belum bisa berkomunikasi)
 - Catat Lokasi, intensitas, durasi, factor yang memperberat/ meringankan.
 - 2) Gunakan instrumen'Dokumentasi
 - Pilih skala sesuai usia
 - Skor hasil skrinning nyeri
 - 3) Dokumentasi
 - Catat skor nyeri, waktu, tindakan dan respons pasien di rekam medis.
 - 4) Tindak lanjut
 - Nyeri ringan (1-3) → observasi, intervensi non farmakologi
 - Nyeri sedang (4-6) → intervensi farmakologi + non farmakologi
 - Nyeri berat (7-10) → analgetic kuat sesuai standar WHO Pain Ladder + evaluasi cepat
 - 5) Evaluasi
 - Ulangi skrinning setelah intervensi (30-60 menit)
 - Dokumentasi hasil ulang

5.1.4 Skrinning nyeri pada pasien koma

a. Instrumen skrinning nyeri

1) Behavioral Pain Scale (BPS) – untuk pasien dewasa koma di ICU

Menilai 3 komponen:

- Ekspresi wajah (relaks, tegang, mengernyit)
- Gerakan anggota tubuh (tidak ada, fleksi, tarikan, gelisah)
- Adaptasi dengan ventilator/ tangisan (sinkron, batuk, melawan ventilator)
- Skor 3-12 → semakin tinggi, semakin nyeri

2) Critical Care Pain Observation TOOL (CPOT)

Menilai 4 aspek.

- Ekspresi wajah
- Gerakan tubuh
- Toleransi terhadap ventilator/ suara tangisan (bila tanpa ventilator)
- Tegangan otot
- Skor 0-8 → ≥ 3 = nyeri signifikan

3) FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)

- Bisa digunakan pada anak atau pasien dewasa tidak sadar
- Skor 0-10 → semakin tinggi skor, semakin berat nyeri

b. Prosedur skrinning

1) Observasi

- Lakukan saat kondisi tenang (baseline)
- Ulangi saat prosedur (misalnya suction, mobilisasi)

2) Skoring

- Gunakan BPS atau CPOT untuk dewasa koma
- Gunakan FLACC untuk anak koma
- Catat skor nyeri

3) Dokumentasi

- Tulis skor, waktu dan kondisi
- Catat intervensi analgesic yang diberikan

4) Tindak lanjut

- Skor rendah ($BPS \leq 3$, $CPOT < 3$, $FLACC 0-2$) → observasi rutin
- Skor sedang – berat ($BPS > 4$, $CPOT \geq 3$, $FLACC \geq 4$) → laporkan ke DPJP, lakukan intervensi analgesic sesuai protocol.

5) Evaluasi

- Ulangi skrinning 30-60 menit setelah intervensi
- Bandingkan hasil dengan baseline

5.2 Tata laksana mengatasi nyeri

a. Penilaian awal

1) Lakukan skrinning nyeri pada semua pasien

2) Dokumentasikan intensitas, Lokasi, durasi, factor pencetus dan respon pasien

3) Identifikasi jenis nyeri : akut, kronis, nociceptive, neuropatik, kanker atau nyeri terminal

b. Intervensi farmakologis

Tabel 5.2.1 Intervensi Farmakologis berdasarkan Tingkat Nyeri

No	Skor Nyeri	Kategori Nyeri	Penatalaksanaan
1	1 – 3	Nyeri Ringan	• Non opioid analgesic : Parasetamol, NSAID • Adjuvan : antidepressant, antikonvulsan (bila neuropatik)
2	4-6	Nyeri Sedang	• Opioid lemah : Tramadol, Kodein • Non opioid (Parasetamol/ NSAID)
3	7-10	Nyeri Berat	• Opioid kuat : Morfin, Oksikodon, Fentanil • Non opioid

c. Intervensi non farmakologis

- 1) Fisik : kompres hangat/ dingin, massage, fisioterapi
- 2) Psikologis : relaksai, distraksi, guided imagery, music terapi
- 3) Spiritual dan edukasi : dukungan keluarga, doa, konseling
- 4) Perawatan invasive khusus (oleh DPJP spesialis) : nerve block, epidural analgesia, PCA (*Patient Controlled Analgesia*).

5.3 Edukasi nyeri

a. Tujuan edukasi

- 1) Memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga tentang nyeri dan penanganannya.
- 2) Membantu pasien berpartisipasi aktif dalam manajemen nyeri
- 3) Mengurangi kecemasan pasien dan keluarga terkait penggunaan obat analgesik
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap rencana terapi
- 5) Menjamin dokumentasi edukasi sesuai standar akreditasi.

b. Sasaran edukasi

- Pasien : dewasa, anak (dengan metode sesuai usia)
- Keluarga/ pendamping pasien : terutama bila pasien tidak mampu berkomunikasi

c. Materi edukasi

- 1) Pemahaman dasar tentang nyeri
 - Nyeri Adalah pengalaman subjektif, bisa berbeda antar individu
 - Nyeri harus dilaporkan secara jujur agar bisa ditangani dengan baik
 - Nyeri merupakan tanda vital kelima yang rutin dinilai oleh tenaga kesehatan
- 2) Instrumen penilaian nyeri
 - Dewasa : NRS, VAS, VRS
 - Anak : Wong Baker Faces, FLACC
 - Ajarkan pasien/keluarga cara melaporkan intensitas nyeri (misal : Skor 0-10)
- 3) Penatalaksanaan nyeri
 - Farmakologis
 - Non farmakologis
- 4) Peran pasien dan keluarga
 - Melaporkan nyeri segera (tidak menunggu nyeri semakin parah)
 - Menggunakan skala nyeri sesuai instruksi

-
- Mendukung kepatuhan terapi obat
 - Membantu memantau efek samping
- d. Metode edukasi
- 1) Komunikasi langsung (tatap muka, bedside teaching)
 - 2) Media cetak/ leaflet tentang skala nyeri dan cara penanganan
 - 3) Audivisual (video edukasi di ruang tunggu/ ruang rawat)
 - 4) Simulasi (cara melaporkan nyeri dengan skala)
- e. Waktu edukasi
- 1) Saat awal masuk rumah sakit (assesmen awal)
 - 2) Sebelum tindakan/ prosedur yang berpotensi menimbulkan nyeri
 - 3) Selama perawatan bila ada perubahan kondisi nyeri
 - 4) Sebelum pulang untuk melanjutkan perawatan di rumah.
- f. Dokumentasi
- 1) Edukasi dicatat dalam rekam medis, meliputi :
 - Materi yang disampaikan
 - Metode edukasi
 - Nama pemberi edukasi
 - Tanda tangan pasien/ keluarga penerima edukasi
 - 2) Gunakan formulir edukasi pasien sesuai standar RS

BAB VI

PELAYANAN MENJELANG AKHIR KEHIDUPAN

6.1. Pengkajian pada pasien menjelang akhir kehidupan harus menilai kondisi pasien seperti:

- 1) Manajemen gejala dan respons pasien, termasuk mual, kesulitan bernapas, dan nyeri.
- 2) Faktor yang memperparah gejala fisik.
- 3) Orientasi spiritual pasien dan keluarganya, termasuk keterlibatan dalam kelompok agama tertentu.
- 4) Keprihatinan spiritual pasien dan keluarganya, seperti putus asa, penderitaan, rasa bersalah.
- 5) Status psikososial pasien dan keluarganya, seperti kekerabatan, kelayakan perumahan, pemeliharaan lingkungan, cara mengatasi, reaksi pasien dan keluarganya menghadapi penyakit.
- 6) Kebutuhan bantuan atau penundaan layanan untuk pasien dan keluarganya.
- 7) Kebutuhan alternatif layanan atau tingkat layanan.
- 8) Faktor risiko bagi yang ditinggalkan dalam hal cara mengatasi dan potensi reaksi patologis.
- 9) Pasien dan keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan asuhan.

6.2 Skrinning Pelayanan Pasien Menjelang Akhir Kehidupan

Skrinning bertujuan mengidentifikasi pasien yang membutuhkan intervensi, sehingga tim kesehatan dapat melakukan assesmen komprehensif, perencanaan tujuan perawatan (*advance care planning*).

- a. Siapa yang melakukan skrinning
 - 1) Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dan/atau perawat triase/ penanggung jawab asuhan.
 - 2) Skrinning dapat difasilitasi oleh petugas gawat darurat, petugas rawat inap, hasil wajib dicatat dalam rekam medis.
- b. Kapan skrinning dilakukan
 - 1) Saat masuk/ fasilitas baru (rawat inap, IGD atau rujukan)
 - 2) 48 – 72 jam setelah opname jika kondisi tetap kompleks atau menurun.
 - 3) Pada setiap kunjungan rawat jalan untuk penyakit kronis progresif.
 - 4) Pada perubahan fungsi/ penurunan berat badan/ peningkatan frekuensi opname.
 - 5) Sebelum dan setelah tindakan invasive besar atau penghentian terapi.
- c. Triger/ indikator awal
 - 1) Klinis/ Prognostik
 - 2) Penyakit stadium lanjut (misal, kanker metastatik, gagal organ tahap akhir, PPOK stadium lanjut, gagal jantung refrakter, gagal ginjal terminal)
 - 3) Utilisasi pelayanan
 - 4) ≥ 2 kali opname/ kunjungan IGD dalam 6 bulan terakhir untuk kondisi terkait kronis
 - 5) Gejala yang sulit dikendalikan
 - 6) Nyeri intensitas sedang – berat tidak responsive standar, dispnea menetap, mual muntah refrakter, delirium, luka tekanan progresif.
 - 7) Kebutuhan psikososial/ spiritual

- Kecemasan berat, keinginan untuk menghentikan terapi, dukungan keluarga minim, butuh diskusi *advance care planning*.

6.3 Proses Manajemen Pelayanan Pasien Menjelang Akhir Kehidupan

- Identifikasi pasien
Pasien dengan prognosis terbatas (≤ 6 bulan hidup) atau kondisi tidak responsive terapi kuratif.
- Assesmen komprehensif
 - 1) Medis : nyeri, dispnea, mual, kesadaran
 - 2) Psikologis : kecemasan, depresi, stress
 - 3) Sosial : dukungan keluarga, ekonomi
 - 4) Spiritual : keyakinan, kebutuhan rohani
- Perencanaan perawatan (Advance Care Planning)
 - 1) Diskusi terbuka dengan pasien (jika sadar dan kompeten) dan keluarga
 - 2) Dokumentasi Keputusan :
 - Resusitasi (Do Not Resuscitate/DNR)
 - Pemberhentian terapi progresif
 - Focus perawatan suportif dan paliatif
- Pelaksanaan Tindakan
 - 1) Kontrol nyeri dan gejala : analgesic, opioid, antiemetic, oksigen, dll
 - 2) Dukungan emosional : konseling, terapi psikososial
 - 3) Dukungan spiritual : pendampingan Rohani sesuai agama/ kepercayaan
 - 4) Perawatan dasar : nutrisi, hidrasi, kebersihan, kenyamanan
- Dukungan keluarga
 - 1) Edukasi tentang proses kematian yang alami
 - 2) Memberikan kesempatan mendampingi pasien
 - 3) Konseling berduka (*bereavement support*)
- Dokumentasi
 - Semua Keputusan, asesmen, dan intervensi harus terdokumentasi dalam rekam medis sesuai standar akreditasi

6.4 Do Not Resuscitate (DNR)

- Prinsip pelaksanaan DNR
 - 1) Pasien first : Keputusan berdasarkan kepentingan terbaik pasien.
 - 2) Informed decision : harus ada penjelasan yang komprehensif dan pemahaman dari pasien/keluarga.
 - 3) Etis dan legal : sesuai hukum, etika profesi dan kebijakan rumah sakit
 - 4) Tidak diskriminatif : Keputusan DNR bukan karena usia, disabilitas atau alasan non medis.
 - 5) Dokumentasi jelas : setiap Keputusan harus tercatat dalam rekam medis dan diinformasikan.
- Indikasi dan pertimbangan DNR
 - 1) Penyakit terminal (stadium akhir kanker, gagal organ multiple, dll)
 - 2) Tidak responsive terhadap terapi kuratif/ agresif.
 - 3) Prognosis sangat buruk (kemungkinan sembuh/ bertahan hidup sangat kecil)
 - 4) Resusitasi diperkirakan tidak bermanfaat atau justru menambah penderitaan.
 - 5) Permintaan pasien yang kompeten secara hukum
 - 6) Permintaan keluarga/ wali sah (jika pasien tidak kompeten)
- Proses pengambilan Keputusan
 - 1) Identifikasi pasien

-
- Dilakukan oleh DPJP atau tim medis, dengan penilaian prognosis dan potensi manfaat resusitasi.
- 2) Diskusi dan edukasi
 - DPJP menjelaskan kondisi medis, prognosis, risiko dan manfaat resusitasi, serta alternatif perawatan (paliatif)
 - Komunikasi dilakukan secara empatik, terbuka dan terdokumentasi.
 - 3) Persetujuan DNR
 - Bila pasien sadar dan kompeten → pasien dapat menandatangani formulir DNR
 - Bila pasien tidak kompeten → keluarga inti/ wali sah yang memberikan persetujuan
 - Persetujuan harus mengikuti Permenkes tentang *informed consent*.
 - 4) Penetapan
 - Keputusan ditetapkan oleh DPJP (bisa bersama komite medis/ komite etik bila kompleks)
 - Keputusan dituangkan dalam Formulir DNR resmi rumah sakit.
 - 5) Dokumentasi
 - Catat di rekam medis : alasan medis, hasil diskusi, persetujuan pasien/keluarga dan tanda tangan pihak terkait
 - Status DNR harus jelas terlihat di rekam medis
- d. Pelaksanaan
- Bila terjadi henti jantung/ napas → tidak dilakukan resusitasi
 - Tetap dilakukan *comfort care* : pemberian oksigen, obat untuk mengurangi nyeri/ sesak, perawatan kebersihan, dukungan *psikologis-spiritual*.
- e. Evaluasi
- Keputusan DNR dapat ditinjau ulang bila kondisi pasien berubah atau pasien/ keluarga menarik Keputusan.
 - Audit mutu rumah sakit dapat memasukkan Keputusan dokumentasi DNR sebagai indikator mutu.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien disusun dalam rangka memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan yang bermutu, aman, efektif dengan mengutamakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, disetiap rumah sakit dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam panduan ini dan dapat mengembangkannya sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 September 2025
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah